UNIVERSITÉ CÔTE D'AZUR
FACULTÉ DE MÉDECINE

Département de Pédagogie

Pédiatrie
Examen du nouveau-né

Nom du rédacteur : Faule Manon, Darmon Julie, Peruzzi Manon

Date de rédaction : 26/09/2023

Relecture intra-ou transdisciplinaire : Mathilde Mayerus ; Julie Bernardor

Situation de départ N° 39 – Examen du nouveau-né à terme

Domaine de compétence principal: Stratégie de prise en

charge **Domaine de compétence secondaire:** Education

/prévention

Attendus d'apprentissage de la situation abordée :

1- Effectuer un examen clinique détaillé du nouveau-né (poids,PC,taille) et détecter d'éventuelles malformations

2- Repérer les situations à risque et proposer un suivi médico-social adapté

Objectifs de la station :

1. Item 32 : Évaluation et soin du nouveau-né à terme

Patient simulé nécessaire à la station :

Non Matériel nécessaire à la station

- Mannequin Non
- Brancard NON
- **Ordonnances vierge**

UNIVERSITÉ
CÔTE D'AZUR
FACULTÉ
DE MÉDECINE

Département de
Pédagogie

UNIVERSITÉ CÔTE D'AZUR
FACULTÉ DE MÉDECINE

Département de Pédagogie

Instructions à l'étudiant

Vous êtes interne dans le service de maternité.

Vous êtes appelé pour effectuer l'examen clinique à J2 du nouveau-né Jade Dupont, 2.25 kg pesée à la naissance, par voie basse, en siège. La mère, Mme Dupont, primipare, est âgée de 25 ans et n'a pas d'antécédent particulier. Sa grossesse a été bien suivie sans complication. Elle souhaite un allaitement maternel exclusif.

Vous avez **8 minutes** pour :

1. Enoncer les principaux éléments à rechercher au cours de l'examen clinique du nouveau-né
2. Réaliser les prescriptions de sortie pour ce nouveau-né

UNIVERSITÉ CÔTE D'AZUR
FACULTÉ DE MÉDECINE

Département de Pédagogie

Fiche de correction pour l'évaluateur (sans le barème)

	Cocher si fait
Tâche 1	
Recherche une émission de méconium dans les 48 premières heures de vie *Ou* recherche un retard d'émission de méconium	
Élimine un ictère néonatal cutanéo-muqueux (ok si seulement "ictère")	
Recherche la présence des pouls fémoraux et d'un souffle cardiaque (pas de point si un seul item énoncé)	
Recherche d'une instabilité de hanche ou d'un ressaut Ou énonce la réalisation de la manoeuvre de Barlow	
Recherche la présence des réflexes archaïques ou automatismes primaires: Au moins 3 sur 6 : grasping, succion, de Moro, marche automatique, points cardinaux, allongement croisé	
Recherche une poursuite oculaire	
Énonce la réalisation de la mesure du périmètre crânien + poids + taille	
Recherche l'absence de fossette sacro-coccygienne pathologique ou recherche une touffe de poils	
Énonce la palpation de la fontanelle antérieure	
Recherche l'absence de hernie inguinale (« inguinale » obligatoire pour le point)	
Recherche la présence d'OGE de type féminin Ou élimine une anomalie de la différenciation sexuelle	
Tâche 2	
Prescrit la vitamine D quotidiennement (doit préciser la fréquence)	
Prescrit la vitamine K à 1 mois de vie (doit préciser le délai)	
Prescrit l'échographie des hanches à un mois (doit préciser le délai)	
COMPÉTENCES GÉNÉRIQUES	
Aptitude à mener l'examen clinique	1 à 5
Aptitude à proposer une prise en charge	
Communication non verbale	

UNIVERSITÉ CÔTE D'AZUR
FACULTÉ DE MÉDECINE

Département de Pédagogie

Fiche de correction avec le barème : non communiqué à l'évaluateur

Tâche 1	
Recherche une émission de méconium dans les 48 premières heures de vie *Ou* recherche un retard d'émission de méconium	3
Élimine un ictère néonatal cutanéo-muqueux (ok si seulement « ictère)	3
Recherche la présence des pouls fémoraux et d'un souffle cardiaque (pas de point si un seul item énoncé)	4
Recherche d'une instabilité de hanche ou d'un ressaut Ou énonce la réalisation de la manœuvre de Barlow	4
Recherche la présence des réflexes archaïques ou automatismes primaires: Au moins 3 sur 6 : grasping, succion, moro, marche automatique, points cardinaux, allongement croisé	3
Recherche une poursuite oculaire	2
Énonce la réalisation de la mesure du périmètre crânien	2
Recherche l'absence de fossette sacro-coccygienne pathologique	2
Énonce la palpation de la fontanelle antérieure	2
Recherche l'absence de hernie inguinale (« inguinale » obligatoire pour le point)	2
Recherche la présence d'OGE de type féminin Ou élimine une anomalie de la différenciation sexuelle	2
Tâche 2	
Prescrit la vitamine D quotidiennement (doit préciser la fréquence)	3
Prescrit la vitamine K à 1 mois de vie (doit préciser le délai)	3
Prescrit l'échographie des hanches à faire dans le mois (doit préciser le délai)	3
Précise le poids de l'enfant sur l'ordonnance	2
COMPÉTENCES GÉNÉRIQUES	
Aptitude à mener l'examen clinique	1 à 5
Aptitude à proposer une prise en charge	
Communication non verbale	

Annexe : Fiche LiSA

Fiche LiSA:Évaluation et soins du nouveau-né à terme

Fiche LiSA | **Fiche LiSA**

Pour imprimer la fiche complète, cliquez sur `Ctrl + P`

- Évaluation clinique du nouveau-né à terme : connaître l'examen clinique du nouveau-né
- Évaluation clinique du nouveau-né à terme : connaître les critères pédiatriques de maturation d'un nouveau-né à terme
- Connaître la prise en charge en salle de naissance
- Connaître les dépistages systématiques néonatals
- Connaître les autres dépistages
- Promouvoir la qualité des premiers liens affectifs parents-enfant et expliquer les bases de la puériculture
- Reconnaître les situations à risque et les situations pathologiques nécessitant une prise en charge spécialisée
- Savoir reconnaître une fente palatine et en connaître la fréquence

Évaluation clinique du nouveau-né à terme : connaître l'examen clinique du nouveau-né OIC-032-01-B

Objectif de connaissance	
Identifiant	OIC-032-01-B
Item parent	Évaluation et soins du nouveau-né à terme
Rang	B
Intitulé	Évaluation clinique du nouveau-né à terme : connaître l'examen clinique du nouveau-né
Description	Evaluation de l'adaptation à la vie extra-utérine Examen standardisé d'un nouveau-né
Rubrique	Diagnostic positif
Contributeurs	Guillaume Mortamet
Ordre	1

L'adaptation à la vie extra-utérine s'évalue par le score d'Apgar à 1, 5 et 10 minutes.

Paramètres	**0**	**1**	**2**
Battements cardiaques	Absents	< 100/ minute	> 100 :minute
Mouvements respiratoires	Absents	Lents, irréguliers	Vigoureux avec cris
Tonus musculaire	Nul	Faible (légère flexion des extrémités)	Fort (quadriflexion, mouvements actifs)
Coloration	Globalement bleue ou pâle	Corps rose Extrémités bleues	Globalement rose
Réactivité à la stimulation	Nulle	Faible (grimace)	Vive (cris, toux)

Un premier examen clinique du nouveau-né est réalisé en salle de naissance. Un deuxième examen clinique complet et détaillé doit être effectué au cours du séjour en maternité, obligatoirement avant le 8ème jour de vie. L'examen est consigné dans le carnet de santé et le pédiatre établit le premier certificat de santé (certificat du 8ème jour). L'examen a lieu en présence d'au moins un des deux parents, dans des conditions adéquates (pièce éclairée, température adaptée, à distance d'une alimentation, respect des règles d'hygiène).

1. **Aspect général** - température (36,5°C-37,5°C) ; - mensurations de naissance (poids, taille et périmètre crânien avec détermination de la trophicité) **(Anomalies de la croissance staturo-pondérale)** ; - inspection : coloration (rose vif voire érythrosique, à l'exception des extrémités qui peuvent rester cyaniques), position au repos (quadriflexion), gesticulation spontanée (symétrique, harmonieuse), vigilance, tonus, interactions visuelles et auditives.
2. **Examen cardiovasculaire** - fréquence cardiaque au repos (entre 120 et 160 battements par minute) ; - temps de recoloration cutané (< 3secondes) ; - recherche d'un souffle cardiaque **(Découverte d'anomalies à l'auscultation cardiaque)** ; - palpation des pouls périphériques, notamment les pouls fémoraux (coarctation de l'aorte) ; - auscultation de la fontanelle antérieure (malformation artério veineuse) **(Découverte d'un souffle vasculaire)**.
3. **Examen pulmonaire** - respiration nasale, silencieuse, régulière, parfois périodique, sans signe de détresse respiratoire (fréquence respiratoire au repos entre 40 et 60 par minute) ; - murmure vésiculaire symétrique, sans bruit ajouté **(Découverte d'anomalie à l'auscultation pulmonaire)**.
4. **Examen du tronc, de l'abdomen et des orifices herniaires** - abdomen souple et dépressible. Recherche d'organomégalie. Le foie peut être palpé (1 à 2 cm du rebord costal) ; - premières urines émises avant 24 heures de vie ; - premières selles (méconium : selles épaisses et collantes, de couleur noirâtre) émises avant 48 heures. En cas de retard d'émission du méconium, vérifier la perméabilité de l'anus ; - examen de la marge anale (malformation ano-rectale).
5. **Examen des organes génitaux externes**

- recherche d'anomalie de la différenciation sexuelle (**Découverte d'une malformation de l'appareil génital)** ;

- chez le garçon : pas de décalottage, palpation des deux testicules, hydrocèle fréquente **(Anomalie des bourses)** ;

- chez la fille : présence de l'orifice vaginal, leucorrhées et métrorragies possibles.

1. **Examen cutané (Tache cutanée du nourrisson)** - peau recouverte du vernix caseosa, enduit blanc graisseux et adhérent qui disparait au cours des premières heures de vie ; - recherche d'ictère cutanéo-muqueux **(Ictère chez le nouveau-né)** ; - recherche d'angiomes plans ou d'hémangiomes ; - particularités sémiologiques non pathologiques transitoires : œdèmes (palpébraux, pieds, mains, scrotum, pubis), lanugo, grains de milium, érythème dit « toxique », livedo, tache ethnique.
2. **Examen de la tête et de la face** - palpation des fontanelles (souples, ni déprimées ni bombées) ; - recherche d'une bosse séro-sanguine ou d'un céphalhématome ; - examen du cou : mobilité passive et active (en cas de torticolis : caractère réductible ou non, recherche d'un hématome des muscles sterno-cléido-mastoïdiens) ; - examen de la cavité buccale : recherche d'une fente vélopalatine et d'un frein de langue court.
3. **Examen neurosensoriel (Anomalie du développement psychomoteur)** - tonus passif et actif ; - automatismes primaires (ou réflexes archaïques) ; - comportement global : éveil calme, réactivité à la stimulation, cri franc, capacité à être consolé facilement, motricité riche, harmonieuse, symétrique ; - fonctions sensorielles : poursuite oculaire, réaction aux bruits et à la voix.
4. **Examen ostéoarticulaire** - palpation du rachis sur toute sa longueur (anomalie de fermeture du tube neural) ; - intégrité morphologique des membres, amplitudes articulaires ; - examen des hanches ; - lésions traumatiques du *per-partum* (paralysie faciale, paralysie du plexus brachial, fracture de clavicule) **(Paralysie faciale)**.

Évaluation clinique du nouveau-né à terme : connaître les critères pédiatriques de maturation d'un nouveau-né à terme OIC-032-02-B

Objectif de connaissance	
Identifiant	OIC-032-02-B
Item parent	Évaluation et soins du nouveau-né à terme
Rang	B
Intitulé	Évaluation clinique du nouveau-né à terme : connaître les critères pédiatriques de maturation d'un nouveau-né à terme
Description	connaitre les éléments pris en compte pour évaluer la maturation d'un nouveau-né (tonus, réflexes archaïques)
Rubrique	Diagnostic positif
Contributeurs	Guillaume Mortamet
Ordre	2

L'âge gestationnel est déterminé à l'échographie précoce (10-12 semaines d'aménorrhée (SA)) ou à défaut à partir de la date des dernières règles. La naissance est dite « à terme » si elle a lieu entre 37 et 41 SA.

La maturation du nouveau-né s'évalue cliniquement par des critères morphologiques et neurologiques notamment le tonus et les réflexes archaïques **(Examen du nouveau-né à terme)**.

---

1. **Tonus néonatal**
   1. Tonus passif (plus le nouveau-né est mature, plus sa posture est en flexion) : - posture spontanée en quadriflexion ; - retour en flexion des membres supérieurs après extension par l'examinateur ; - signe du foulard ; - examen des angles : angle poplité (≤90°), dorsiflexion du pied (entre 0 et 20°), angle talon-oreille (≤90°), angles des adducteurs (entre 40 et 70°).
   2. Tonus actif : - manœuvre du tiré-assis ; - redressement complet.
2. **Automatismes primaires (ou réflexes archaïques)** Présents chez le nouveau-né à terme : succion, points cardinaux, agrippement, réflexe de moro, allongement croisé, marche automatique. Absence toujours pathologique. Disparition entre 2 et 4 mois de vie.